本章数字资源

第一章 全科医学概述

学习提要

- 20 世纪后期产生的全科医学有其悠久的历史渊源，更有鲜明的时代特征。
- 全科医学是一门临床二级学科，具有独特的医学观和方法论以及系统的学科理论。
- 全科医生身兼医生、教育者、沟通者、管理者、“守门人”和组织协调者等多种角色，应具备综合的专业素质，并需要经过严格的专业训练。
- 全科医疗与专科医疗，全科医学与社会医学、社区医学、替代医学既有联系又有区别。
- 全科医生岗位胜任力是全科医生培养与评价的依据。
- 全科医学是整合医学的枢纽，全科医生是整合医学的协调员。

全科医学（general practice）又称家庭医学（family medicine），起源于近代的通科医疗，作为一门临床二级学科，诞生于 20 世纪 60 年代末期。从 20 世纪 90 年代初开始，伴随着社会经济的快速发展、人民生活水平的逐步提高，以及城乡居民对健康需求的不断变化，在政府的大力推动、全科医学及其他各学科专家同道的共同努力以及社会各界的广泛支持下，全科医学这门学科在我国正式建立并得到快速发展。

第一节 | 全科医学的产生与发展

一、全科医学产生的基础

古代的医生在中国被称为“郎中”，在西方被称为“healer”，即“医治者”，那时医生并不分科。这些古代医生运用朴素的自然哲学医学理论，并对患者进行细致观察，采用各种治疗手段（包括药物、针灸、按摩、放血等）帮助患者从病理不平衡状态恢复到身体与精神的平衡状态。当然，伴随着科学和技术的进步，医学对疾病的病因和发病机制认识不断深入，定位精确、技术先进的现代医学应运而生。

百年来近代医学的发展，使人们对于疾病和人体有了更为精确和深入的了解。1857 年巴斯德发现细菌是许多疾病的病因；1863 年孟德尔著名的豌豆杂交实验发现生物遗传规律；1895 年伦琴发现 X 射线；1940 年青霉素开始应用于疾病的治疗等。詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克提出的 DNA 双螺旋结构已成为生物学自达尔文以来最重要的发现，其深刻影响一直延续至今。在此基础上，医学技术迅猛发展，许多严重的感染如败血症、细菌性心内膜炎等都可被治愈，恶性肿瘤可以被切除，器官可以移植。现代医学的发展使人类的预期寿命大大延长。

第二次世界大战后，借助于近代医学科学的成就，各临床医学专科迅猛发展，专科医生和亚专科医生数量剧增，而全科医生数量骤减。人们发现医疗卫生服务被割裂成为各个专科服务的片段，缺乏能提供连续性、综合性医疗服务的医生。同时，在现代医学高度发展的今天，仍然有许多的疾病无法治愈，很多病痛无法解除。当人们认识到现代医学仍有其方法与应用上的局限性，全科医学个体化的基本医疗照顾重新得到重视和发展。然而，获得重生的全科医学并非回到古代医学中，而是建立在现代医学科学、医学心理学、社会医学和行为医学等科学的基础之上的新的学科。

NOTES

现代全科医学的崛起，是与人口迅速增长与老龄化、疾病谱与死因谱的变化、医学模式转变、医疗费用快速上涨等密切相关的。

（一）人口迅速增长与老龄化

随着各国社会经济条件普遍改善，健康卫生事业快速发展，人类越来越长寿，人口也迅猛增长。人口老龄化问题逐渐成为全球性的社会问题。国际公认的人口老龄化标准是 60 岁及以上人口超过总人口的 10%，或 65 岁及以上人口超过总人口的 7%。许多国家 60 岁及以上人口所占的比例日趋增大，许多发达国家在 20 世纪 50 年代即进入了老龄化社会。我国在 2000 年正式进入老龄化社会。截至 2021 年，我国 60 岁及以上人口已达 2.64 亿，占总人口的 18.70%。

人口老龄化给社会带来了巨大的压力。一方面，社会劳动人口比例下降，需要赡养的老年人比例明显增大，使社会的经济负担加重；另一方面，进入老年后，生理功能衰退，慢性退行性疾病逐渐增多，行为能力减退，社会地位和家庭结构以及心理、精神方面出现变化，使老年人的生活质量全面下降，“长寿”和“健康”成为两个相互矛盾的目标。而高度专科化的生物医学模式因其医疗服务的狭窄性、片段性和费用昂贵，加剧了这一矛盾。怎样帮助老年人全面提高生活质量，使其得以安度晚年，成为 20 世纪 60 年代以来各国公众和医学界共同关注的热门话题。

（二）疾病谱与死因谱的变化

20 世纪 40 年代，抗生素的成功研制，拯救了许多严重感染的患者，给人类带来了巨大希望。由此开始，千百年来影响人类健康的传染病得到控制。传染病和营养不良症在疾病谱和死因谱的顺位逐渐下降，而慢性退行性疾病、与生活方式及行为有关的疾病等却逐渐成为影响人类健康的主要因素，我国慢性病总体死亡人数占到了全部死亡人数的 88.5%，因心脑血管疾病、癌症和慢性呼吸系统疾病死亡的人数占全部死亡人数的 80.7%。疾病谱的变化向现代医学及医疗服务系统提出了新的要求：服务时间要求长期而连续；服务内容要求生物、心理、社会、环境全方位；服务地点要求以家庭和社区为主；服务类型要求综合性的照顾（包括医疗、预防、康复、保健、教育、咨询等干预）重于单独医疗干预；服务方式要求医患双方协商，强调患者主动和自觉地参与，而不仅仅是被动地遵从医嘱。

（三）医学模式转变

所谓医学模式，是指医学整体上的思维方式或方法，即以何种方式解释和处理医学问题。医学模式受到不同历史时期的科学、技术、哲学和生产方式等多方面的影响，人类历史上出现了多种不同的医学模式，如古代神灵主义医学模式、自然哲学医学模式、近代机械论医学模式以及现代生物医学模式、生物-心理-社会医学模式。

生物医学模式是把人看作生物体，致力于寻找每一种疾病特定的病因和病理生理变化，并研究相应的生物学治疗方法。生物医学模式在特定的历史阶段对防治疾病、维护人类健康作出了巨大贡献，而且一直是现代医学界占统治地位的思维方式，也是大多数专科医生观察、处理其研究领域内问题的基本方法。但生物医学模式无法解释某些疾病的心理社会因素，以及疾病造成的种种身心不适，无法解释生物学与行为科学的相关性，更无法解决慢性病患者的心身疾患和生活质量降低等问题。随着疾病谱的变化和病因、病程的多样化，生物医学模式的片面性和局限性也日益显现。自 19 世纪末以来，随着预防医学、流行病学、行为科学、心身医学、免疫学、医学哲学等领域的发展，系统论的思维逐渐被接受，从而产生了新的医学模式。

生物-心理-社会医学模式的概念是由美国医生 G.L.Engle 于 1977 年首先提出的，是一种多因多果、立体网络式的系统论思维方式。它认为人的生命是一个开放系统，通过与周围环境的相互作用以及系统内部的调控决定健康状况。因此，生物医学仍是这一模式的基本内容之一，但其还原方法却被整合到系统论的框架中，与整体方法协调使用。无论是医学的科学特征、医生的诊疗模式还是医疗保健事业的组织形式，都应根据新的模式进行调整，使其适应医学模式转变的需要。

（四）医疗费用快速上涨

20 世纪 60 年代，各国都面临医疗费用的快速增长问题，其主要原因是高技术医学的发展和人口

老龄化。高技术医学的发展使医疗投入急剧增长，而对改善人类总体健康状况却收效甚微，即成本的投入与其实际效果/效益相距甚远。有资料表明，85% 以上的卫生资源消耗在 15% 的危重患者治疗上，而仅有 15% 的资源用于大多数人的基本医疗和公共卫生服务。这种资源的不合理配置，不仅使政府不堪重负，还使公众十分不满。因此，人们迫切要求改变现行医疗服务模式，合理利用有限的医疗卫生资源，使其得到及时、方便、优质、价廉的基本医疗卫生服务。

目前世界公认的理想保健体系是正三角形（又称金字塔形）医疗保健体系，其宽大的底部是可以被广大群众利用的、立足于社区、提供基本医疗保健和公共卫生服务的基层医疗服务机构，如全科医疗诊所与社区卫生服务中心；中部是二级医疗服务机构，如医院、慢性病院、护理院和其他能处理需要住院的常见问题的医疗保健机构；顶部是利用高技术处理疑难危重问题的少数三级综合和专科医院。医师人力有一半以上在基层从事社区卫生服务，体现了在卫生资源分配上对社区的倾斜；而所有民众的首诊医疗保健也应在基层解决，体现了在卫生资源利用上对社区的重视。

这种正三角形医疗保健体系意味着不同级别医疗保健机构功能的分化，即不同级别的医疗保健机构各司其职，综合医院集中于疑难危重问题的解决和高技术的研究，并作为基层医疗的学术与继续医学教育的后盾；基层医疗机构则全力投入社区人群的基本医疗保健工作，在医疗保健系统中充分发挥基层医疗和居民健康“守门人”的作用，以较低的医疗费用、有限的卫生资源取得较为理想的居民健康效果。

二、全科医学发展简史

在很久以前，医学基本不分科，那时候的医生大多是通科医生。到 20 世纪上半叶医学专科化发展后，人们开始熟悉内、外、妇、儿的分科方式。随着医学的专科化发展，医生们对于疑难急症的诊治能力越来越强，然而医生在攻克各种疾病的同时，却忽视了患者本身的需求，患者不能在诊疗过程中得到应有的关怀与关注。现代“全科医生”在这样的情况下应运而生，全科医生（家庭医生）也开始逐步组织、成立自己的学术组织。

近代全科医学发展可分为 3 个阶段。

（一）近代的通科医生

全科医学是在通科医疗的基础上发展起来的。18 世纪欧洲向北美大陆的“移民”中，有一部分是医生，然而为数甚少的医生无法满足大量移民的医疗需求，医生不得不打破原有的行业界限，从事内科医生、外科医生、药剂师等多种工作，以各种可能的方式服务于患者，因此通科型的医生在 18 世纪的美洲诞生了。

19 世纪初，英国的 *Lancet* 杂志首次将这类具有多种技能的医生称为“通科医生”（general practitioner，GP），医学生毕业后若通过了内科医疗、药物、外科及接生技术的考试，可获得“通科医生”的执业资格。由于这一名称首先于 19 世纪在欧洲（英国）使用，所以说，通科医生诞生于 18 世纪的美洲，而命名于 19 世纪的欧洲。

在 19 世纪，80% 左右的医生都是通科医生。这些医生在社区执业，为居民及其家庭提供周到细致的照顾，照料全家的疾患，他们是社区民众亲密的朋友、照顾者和咨询者，在社会上备受尊敬。

（二）医学专科化与通科医疗的衰落

19 世纪基础医学的大发展奠定了现代医学的科学基础，新技术的使用和发展导致了临床医疗实践的分化。1910 年在美国，A.Flexner 在对 Johns Hopkins 大学医学院的报告中肯定了该校将临床医疗、教学和科研融为一体的新型教育模式。此后欧美各医学院校便按照不同专业的要求重新组织教学，医疗开始趋向于专科化，医学科学研究逐渐在以医院为主体的临床医疗中占据了中心位置，从此医学便开始了意义深远的专科化进程。专科医疗服务模式的成功，大大提高了医院专科化和医学科研机构的发展，而诊治手段的高科技化，更使专科医疗服务达到了空前的繁荣。

20 世纪以来，科学技术的进步促使医学迅猛发展。医学研究对象逐渐从人体系统、器官、组织、

NOTES

细胞到亚细胞和生物大分子层次，向微观世界的深入使疾病在生物学方面得到精确的定位，形成了众多的二级学科。其对疾病进行了详尽的分类和研究，发展了各种高技术手段，并找到了一系列有效的治疗方法，因此，人们开始崇拜医院和专科医生，而社区中的通科医生被冷落，通科医疗逐渐萎缩。到了 20 世纪 40 年代末，仅有不到 20% 的医生还在社区工作。

（三）专科医疗局限性的显现与通科医疗的复兴

随着专科化的过度发展，其服务模式的内在缺陷也逐渐引起人们的关注。从 20 世纪 50 年代后期起，由于人口老龄化进程加快，以及慢性病、退行性疾病患者的增多，基层医疗保健的重要性重新显现；老年人易患多种疾病，也需要一大批医生在社区和家庭环境中长期陪伴、照顾他们，社会对通科医生的需求开始不断增长。1947 年，成立了美国通科医疗学会，后更名为美国家庭医师学会（American Academy of Family Physicians，AAFP）。1968 年美国家庭医学委员会（American Board of Family Practice，ABFP）成立，于 1969 年成为美国第 20 个医学专科委员会，通常人们将其作为全科医学学科正式建立的标志。在美国，通科医师改称“家庭医师”（family physician），其提供的服务称为“家庭医疗”（family practice），将其知识基础或学科体系称为“家庭医学”（family medicine）。

与此同时，英国与英联邦国家尽管也和美国一样建立了一个新型学科及其培训制度，但未改变 GP 的称谓。此后为了改变人们对“通科医生”只通不专、缺乏专业训练的印象，将“general”的译文从“通”改为“全”，以示其服务全方位、全过程的特点。这样，世界上就有了全科医生和家庭医生这样的“一类医生、两个名称”的情况。

1972 年，世界全科/家庭医生组织（World Organization of National Colleges Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians，WONCA）在澳大利亚墨尔本正式成立，组织为世界全科医生提供学术和信息交流的平台，大大促进了全科医学在世界各地的发展。

三、国外全科医学的发展

（一）美国

美国“家庭医生制度”被称为医疗卫生体系的“守门人”制度、“医疗保险基层就医首诊制度”。美国居民与家庭医生的签约模式是自愿的，但是政府会做出相应的干预。在美国，不同形式的保险服务，决定了你的就医方式，大多数人购买的是管理式保险计划，保险费相对便宜。根据美国保险政策的要求，购买这种保险的居民必须由保险公司指定一名家庭医生，患者看病首先要找自己的家庭医生，除非发生意外情况。如病情较重，要看指定范围外的专科医生，必须通过家庭医生转诊，且事先要征得保险公司的同意。若无家庭医生，患者自己是无法去专科医院就诊的。少数人购买的是自选式保险计划，保险费较贵，患者看病不用通过家庭医生转诊，就能直接看专科医生。尽管如此，此种保险的绝大多数客户也都为自己选择了家庭医生并更愿意由他们来协助转诊，因为家庭医生了解自己的全部诊疗史。在美国，患者的医疗档案是保存在家庭医生那里的。看不看病、什么时候看病、该不该转诊，不仅掌握在患者手中，同时还掌握在医生手中。小病可以由家庭医生解决，大病则可以从他们那里得到专业的意见。如果家庭医生认为有必要，就会将其转诊给专科医生做进一步的检查、诊断和治疗；当病情缓解后，再转回家庭医生。家庭医生与各专科医生是紧密合作的关系，在一般疾病以及慢性病治疗上，由家庭医生协调各专科医生共同管理患者。家庭医生与患者的关系建立在相互信任的基础上，家庭医生不但负责患者的诊断治疗、分流转诊和会诊，而且要撰写综合转会诊报告，同患者探讨诊疗计划，定期随访，并负责平时的健康普查等工作。在美国人心目中，家庭医生是他们的医学顾问和健康守护神，在没有生病的时候，家庭医生负责督促其定期体检，监控健康，防止疾病发生，而且家庭医生日常还要负责教育他们如何更好维护自己的健康；假如生病了，家庭医生是首诊的医生，根据每一个人的医疗档案，制订最合适的治疗方案，判断是否有必要转诊。

美国的家庭医生培养模式为完成 4 年大学本科教育之后，才可以进入医学院校接受 4 年的医学教育，选择全科医学专业的医学生完成 3 年的全科医学住院医师培训（2 年医院+1 年社区诊所）后，

经家庭医师协会的认证，才可以在社区执业。此外，获得执业资格后每 6 年还须参加家庭医生资格的再认证考试。

（二）英国

英国的医疗体系中，全科医疗发挥着巨大的作用。英国国家医疗服务体系（NHS）强化了医疗服务的全民性和公平性，通过购买全科医生个体服务的方式，实现了初级卫生保健的全民覆盖。英国强制居民签约全科医生，居民需要遵循首诊制度和转诊制度。居民必须选择一所全科诊所签约，才能免费享受 NHS 提供的医疗服务，99% 的居民签约了自己的全科诊所。全国 90% 的基层医疗卫生服务需求由全科诊所来完成，而医疗花费仅占整个医疗费用的 9% 左右。居民患病需要转诊时，必须先到签约的全科诊所就诊，只有签约的全科医生认为必要时，患者才会被转诊到上级医院或专科医院。全科医生在转诊前，会与上级医院的专科医生进行电话沟通，确认后开具纸质或者电子的转诊信。但紧急情况除外，如急诊、急性心脑血管疾病发作、意外事故等，患者可以直接到医院就诊。最后，患者在转诊后的相关处理情况和结果都会及时反馈到全科医生这里，便于全科医生为患者做好连续性的健康管理服务。一般全科诊所的转诊率为 5%。英国的全科诊所还负责英国居民的养老服务、临终关怀服务、慢性病的宣传教育。英国居民从出生到死亡大部分就医都是由全科医生负责。简而言之，全科医生是全体英国国民健康的“守门人”和“筛选者”，对所有患者的医疗需求首先进行分类梳理，将常见病、多发病和简单的医疗需求在社区和基层解决，将真正的疑难重症转到综合或专科医院进一步诊治。英国的综合医院一般没有全科医疗病房。近年来，英国全科医疗服务面临重大挑战：全科医疗工作量不断增加，而全科医生数量不足，且人口老龄化、社区诊断和管理的医疗问题日益复杂，患者对全科医疗服务的期望值越来越高。为了应对这些挑战，英国尝试了多学科社区服务和社区-综合医院联合服务两种方式，来解决全科医疗发展中的问题。同时在英国政府提出的解决健康不平等战略中，全科医疗也起到了关键作用。

英国全科医生的培养模式为“5+2+3”，其中前 5 年为医学本科教育，2 年为基础培养，3 年为医院和全科诊所培训。全科医生要求每 5 年重新考核、注册认证 1 次，考核内容包括成本效益、质量改进、医疗投诉、重大事件发生及处理情况、同行评议等。

（三）澳大利亚

澳大利亚通过全民医疗保险（medicare），以按服务收费的方式购买私人全科医生服务，从而实现人人享有初级卫生保健。在澳大利亚，由全科医生作为所有公民的健康守门人，对前来就诊的患者进行评估，根据患者具体状况进行分诊。如须转入专科进一步诊疗，则由全科医生协调转诊。如该患者在某一方面需要特别关注的话，则专科医生诊疗完成后再转回全科医生，并通报此次的诊疗情况及日后管理建议，由全科医生根据患者的生活、心理等整体情况给予进一步的照顾。制度上虽没有一对一的签约模式，但是就诊必须先经过全科医生，而患者的全程管理也由全科医生主导。若居民是首次就诊，那么全科医生还需要对他进行健康评估，建立健康档案。需要医疗照顾的患者会被合理地分配到他们所需要的地方，并根据病情需要上下转诊。全科医生存在于医疗体系的各层面、各环节，充分起到基础健康保障及连接各级别诊疗行为的作用。目前澳大利亚的全科医学存在着一定的危机，存在全科医生短缺与流失、职业吸引力不足、职业倦怠和沮丧更加普遍、农村和偏远地区缺少全科医疗服务等问题。而人员不足、诊所关闭、职业吸引力缺乏的主要原因是全民医疗保险对全科医生服务的购买力度不足。同时由于政府对全科服务购买力不足，患者在全科医疗门诊就医时还需要支付其他的就医费用。为此，澳大利亚正在多措并举，尝试解决。

澳大利亚全科医生的培养为“4+2+4”模式，其中前 4~5 年进行本科教育，随后 2 年为临床科室轮转（住院医生轮转 1 年后获得医生执照），第三阶段 3~4 年在全科医学培训中心，最后通过全科医生学会的资质考试成为独立执业的全科医生。以后每 3 年考核 1 次，考试结果决定定期的职业登记，以及医疗保险是否购买其诊疗服务。澳大利亚的全科医生培训模式特点为个性化、主动性、反思性、持续性。

NOTES

四、国内全科医学的发展与前景

（一）国内全科医学的发展历程与现状

1. 国内全科医学的发展历程　我国港澳台地区开始全科医学工作早于我国其他地区。全科医学概念的引入，经历了萌芽阶段、起步阶段、快速发展阶段，已经进入全面发展阶段。①萌芽阶段（1993 年之前）：20 世纪 80 年代后期，全科医学概念开始引入我国，世界家庭医生组织（WONCA）专家来华介绍全科医学；中华医学会派代表参加 WONCA 年会及亚太地区年会进行交流学习，在 WONCA 专家的帮助下，在首都医科大学的积极推动下，我国开始了中国特色全科医学教育的尝试和探索。②起步阶段（1993—2011 年）：1993 年 11 月，中华医学会全科医学分会成立，表明全科医学开始在我国起步。1995 年 8 月，中华医学会全科医学分会正式成为 WONCA 成员，得到国际认可。1997 年 1 月，中共中央、国务院发布《关于卫生改革与发展的决定》，明确要“加快发展全科医学，培养全科医生”，政府介入大力推进。2000 年 1 月，卫生部发布了《关于发展全科医学教育的意见》，提出了我国全科医学教育发展目标，并陆续出台了全科医生规范化培训和岗位培训大纲，教育培训规范起步。2006 年，国务院发布《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，并出台了 9 个配套文件，对加强城市社区卫生人才队伍建设提出了指导意见，多部门协同推进全科医学发展局面开始形成。2010 年 4 月，国家发展改革委等六部委联合印发《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划》，开始加大农村全科人才培养力度。尽管在该阶段全科医学发展与全科医生队伍建设取得了一定成绩，但仍然存在认识与投入不足、政策落实不到位、发展不平衡等问题。③快速发展阶段（2011—2019 年）：2011 年 7 月，国务院印发《关于建立全科医生制度的指导意见》，提出到 2020 年基本实现城乡每万名居民有 2~3 名合格的全科医生的目标；全科医生培养规范以“5+3”模式为主，“3+2”模式作为补充；同年国务院学位委员会正式批准在临床医学专业学位类别下增设全科医学领域；之后国家相关部委及学会相继出台关于全科师资培训、全科医生培养与使用激励、综合医院独立设置全科医学科、全科医生转岗培训等一系列相关文件，2017 年党的十九大报告特别指出要加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。在国家卫生健康委员会的直接领导下，在中华医学会及全科医学分会、中国医师协会及全科医师分会等学术组织的积极推进下，全科医学得到了迅速发展，全科医生队伍不断壮大。④全面发展阶段（2020 年 1 月至今）：2020 年 9 月国务院办公厅出台《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，明确提出要加大全科医学人才培养力度；600 余家全科临床住院医师规范化培训基地独立设置全科医学科，全科医学进入复旦医院专科排行榜；全国遴选 43 家全科专业住院医师规范化培训重点基地，这些都标志着全科医学进入全面发展阶段。伴随着中国特色社会主义进入新时代，全科医学这门新兴学科也开启了新的发展征程。

2. 国内全科医学的发展现状　全科医学 30 余年的发展取得了显著进步，实力不断攀升。

（1）全科医学学科地位已经确立。①法律层面确立全科医生地位。《中华人民共和国医师法》明确全科医生为国家紧缺专业人才，要求采取多种措施，加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才培养和配备；《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》要求加强全科医生培养和使用，明确了全科医生工作职责，从法律层面确立全科医生地位，体现了全科医学学科的重要性。②住院医师规范化培训基地（综合医院）独立设置全科医学科，推进全科医学学科建设。国家卫生健康委员会出台的《关于印发住院医师规范化培训基地（综合医院）全科医学科设置指导标准（试行）的通知》（国卫办科教发〔2018〕21 号）明确要求认定为住院医师规范化培训基地的综合医院最迟在 2019 年底前均应独立设置全科医学科，为提高全科医生培养质量，完善全科医学学科建设提供了有力支撑。③全科医学进入复旦医院专科排行榜。全科医学 2020 年进入复旦大学医院管理研究所发布的中国医院专科排行榜，预示着全科医学科进入医院主要科室的行列，标志着全科医学学科建设进入新阶段。④完善医疗服务体系的重要内容。目前基层医疗卫生服务薄弱是医疗卫生服务体系存在的主要问题之一，建立符合国情的分级诊疗制度，开展家庭医生签约服务，是解决这一问题的重要举措。这就需要强有力

的以全科医生为主体的基层医疗卫生人才队伍做支撑。提高全科医生培养质量与水平，有利于实现“关口前移、重心下移”，延缓或减少疾病的发生，降低医疗费用，缓解“看病难、看病贵”，不断推进分级诊疗制度的落实落地与家庭医生签约服务高质量发展。⑤实现全民健康的重要支撑。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，把维护人民健康摆在更加突出的位置，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领，不断向实现人人享有健康的美好愿景迈进。加强全科医生培养，发展全科医学有利于落实“预防为主”的方针，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，全方位全周期服务百姓健康，为实现全民健康提供保障。

（2）适合国情的全科医生教育培养体系基本建立。目前我国的全科医学教育培养体系主要包括院校教育、毕业后教育和继续教育三个阶段。全科医学院校教育指的是在高等医学院校进行全科医学理念和基本理论的培训，是全科医学教育的基础。全科医学毕业后教育是全科医学教育的核心，是全科医生培养的主渠道。确立了全科医生规范化培训“5+3”为主，助理全科医生规范化培训“3+2”为辅的培养模式，统一了全科医生规范化培养方法和内容、全科医生的执业准入条件和统一的全科医学专业学位授予标准。全科医学继续教育主要包括转岗培训和继续职业发展。全科医生转岗培训等多渠道全科医生培养工作仍然是加大全科医生培养力度、实现“2030 年每万名城乡居民拥有 5 名全科医生”的重要途径。

（3）全科医疗服务模式初步建立。目前，我国分级诊疗制度建设已经初见成效，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系已经初步建立。基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成。家庭医生签约服务持续推进，初步形成了以全科医生、社区护士为主的团队服务模式，以基本医疗和公共卫生项目服务为主的签约服务。

（4）全科医生职业发展保障环境基本形成。①建立健全适应行业特点的全科医生制度；②全面提升全科医生的职业吸引力；③加强贫困地区全科医生队伍建设。

（5）推动全科医学持续发展的良好氛围已经形成。近年来，各级政府、相关部门领导对全科医学高度重视，相关政策不断出台。医学院校、行业组织、医疗机构积极参与全科医学建设和学术活动。社会各界、媒体和群众对全科医学的关注度明显提升。我国全科医生总数从 2012 年的 11.0 万人增加到 2022 年的 46.3 万人，每万人口全科医生数由 2012 年的 0.8 人增加到 2021 年的 3.3 人。

（二）全科医学发展面临的挑战

1. 人才培养 我国全科医生数量缺口仍然较大。按照 2030 年城乡每万名居民有 5 名合格全科医生的目标，我国至少还缺 26.5 万名全科医生；全科医生培养体系还有待进一步完善，特别是在标准化和规范化方面；全科医生培养质量参差不齐，水平有待进一步提高，目前接受过“5+3”规范化培训的全科医生尚少，全科医生岗位胜任力还须提升；全科医生岗位缺乏基本吸引力，基层全科医生待遇低，职称晋升难，职业发展路径不够清晰；适应全科医生特点的人事薪酬制度尚须完善与落实。

2. 师资培养 全科医学师资仍然不足，教学能力还较薄弱，教学经验较欠缺。全科医学学科带头人及骨干的培养亟待加强；对于其他临床专科兼职教师教学积极性的提升仍须下大力气。

3. 学科建设 目前，医学院校对全科医学学科发展重视程度还不够。全科医学系或学院如何建设尚无定论。面向全体医学生的全科医学课程还没有普遍开设，全科医学专业必修课有待规范。高等院校附属医院/基地医院/基层卫生机构全科医学学科建设尚在探索。综合医院的全科医学科医疗、教学、科研工作如何开展还存在许多问题。

4. 科学研究 目前我国的全科医学科学研究存在多中心联合研究少、中标大课题（如国家自然科学基金等）不多、发表高水平科研文章（如 SCI）尚少、基层医疗卫生服务机构对科研重视不够和全科医生整体科研能力薄弱等问题。当然，一些客观因素也阻碍了我国全科医学科学研究的发展，如全科医学领域申请渠道较少等（国家自然科学基金等大课题没有全科医学方向）。

5. 社会服务 目前基层全科医疗服务尚不规范，服务质量参差不齐；全科医疗服务模式有待进

一步优化，服务效率有待进一步提升。综合医院全科医学科与基层全科医学科联动机制有待探索与明确。

第二节 | 全科医学、全科医疗和全科医生

一、全科医学

（一）全科医学的概念

全科医学（general practice）是社会发展的产物，其为人们提供全面的医疗保健服务，也在医疗服务上满足了综合重组的需要。全科医学又称家庭医学，诞生于 20 世纪 60 年代的美国，并于 20 世纪 80 年代后期传入我国。

我国学者普遍认同的全科医学定义是，全科医学是一个面向个人、社区与家庭，整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性临床二级专业学科；其范围涵盖了各年龄、各性别、各个器官系统以及各类健康问题和疾病。其主旨是强调以人为中心、以家庭为单位、以整体健康的维护与促进为方向的长期负责式照顾，并将个体与群体健康照顾、防和治有机地融为一体。

全科医学具有独特的医学观和方法论以及系统的学科理论，其技术方法更适合于基层医疗卫生服务。全科医学以生物-心理-社会医学模式为理论基础，秉承整体观和系统论的医学思维，建立了一系列独特的基本原则，以此来指导全科医生利用社区内外有限的卫生资源，为社区中的个体及其家庭提供连续性、综合性、协调性、个体化和个性化的医疗保健服务，并最大限度地满足社区居民追求健康生活的需求。

（二）全科医学的学科特点

全科医学主要研究各种类型社区中的常见健康问题以及综合性地解决这些健康问题所需要的理论、方法和技术。其内容主要包括三个方面：一是通过长期的通科医疗实践而积累起来的实践经验；二是从其他医学学科中整合而来的知识与能力；三是通过全科医学专业研究发展起来的特有的理论、态度、知识和技能。具体的学科特点如下。

1. 一门综合性的临床医学学科　全科医学是一门独立的临床医学二级学科，其知识体系可分为总论和各论两个部分。总论部分是全科医学的理论精髓，主要介绍全科医学的理论，包括全科医学的基本原则、全科医学的人文精神、全科医生的临床诊疗思维和岗位胜任力、健康与慢性病管理等；各论部分主要是临床诊疗中常见健康问题的全科医疗处理，包括临床诊疗中常见健康问题的诊断、处理与评价的方法和技术（常见健康问题涉及生理疾病、心理问题和影响健康的社会问题等）。从医疗服务角度来说，全科医学又是一门综合性的临床专科。与其他临床专科明显不同的是，其他临床专科都是在一定领域范围内不断地朝纵深方向发展，向患者提供独特且范围较窄的专科服务；而全科医学则是在一定深度上朝横向发展，并根据服务对象的健康需求，将相关知识、技能有机地整合为一体，向患者提供全面的综合性服务，因而充分体现了现代医学服务模式的优势。

2. 具有地域和民族特点的现代服务模式　全科医疗服务最充分地体现了现代医学模式和医学目标转变的要求，采取了以病人为中心的全面照顾模式。重视发展与患者间长期稳定的合作伙伴关系，强调要对患者及其家庭、社区的健康长期负责；对疾病预防、治疗及康复，医疗服务满意度，卫生资源的有效利用和医疗伦理学问题等全面关注。全科医学的服务领域主要定位于基层医疗卫生服务，主动地为社区居民提供连续性、综合性、个体化的医疗卫生服务，同时通过适宜和有效的干预，积极维护、促进社区居民的健康。

3. 强调整体性的临床思维方法　全科医学用系统论和整体观的方法来理解和解决人群和个体的健康问题，把患者及其健康看成一个整体，注重患者及其健康问题的背景和关系，采取整体性的“生物-心理-社会”医学模式为患者、家庭和社区提供整体服务。全科医学把医学照顾看成为一个整

体，为满足患者及其家庭和社区的需要，经常要协调提供整体性的多学科服务。

与传统经验医学不同，全科医学应用现代医学的研究成果来解释发生在患者身上的局部问题和整体变化。以科学证据为基础，运用流行病学和循证医学的方法评价与处理临床问题，并在医疗服务过程中注重建立良好的医患关系。

4. 高度重视服务艺术 全科医学在强调医学科学的同时，还十分关注服务艺术。“高情感”的全科医学表现为以维护个体长远的总体健康为己任，注重人胜于疾病，注重伦理胜于病理，注重满足患者的要求胜于疾病的诊疗。在强调技术水平的同时，十分注重将其与服务艺术有机地结合为一个整体，使医学成为真正服务于人的科学。

（三）全科医学的主要研究内容

1. 社区常见健康问题的诊疗、管理、康复和预防。

2. 完整的人及其健康问题。即以人为本，以健康为中心，了解患者作为一个完整的个体的特征和需求。

3. 家庭的健康问题。即以家庭为单位，了解家庭与个人之间的关系和家庭对健康的影响。

二、全科医疗

（一）全科医疗的定义

全科医疗（general practice）是将全科/家庭医学理论应用于患者、家庭和社区照顾的一种基层医疗专业服务，是社区卫生服务中的主要医疗服务形式。是一种集合了许多其他学科领域内容的一体化的临床专业；除了利用其他医学专业的内容，还强调运用家庭动力学、人际关系、咨询以及心理治疗等方面的知识技能提供服务。美国家庭医师学会（AAFP）对家庭医疗（即全科医疗）的定义是：“家庭医疗是一个对个人和家庭提供连续性与综合性卫生保健的医学专业，是一个整合了生物医学、临床医学与行为科学的宽广专业。家庭医疗的范围涵盖了所有年龄、性别，每一种器官系统以及各类疾病实体。”

（二）全科医疗的特点

全科医疗是一种以门诊服务为主体的基层医疗保健服务，是社区居民为其健康问题寻求卫生服务时最先接触、最经常利用的专业性服务，是整个医疗保健体系的门户和基础，通常把全科医疗称为首诊服务。除了提供优质的诊疗服务，全科医生还应通过家访和社区调查，关心未就医的患者以及健康人的需求。全科医疗以相对简便、低廉而有效的手段解决社区居民约 80%~90% 的健康问题，并根据需要安排患者及时、适当地利用其他级别或类别的医疗保健服务。全科医疗的特点包括：强调连续性、综合性、个体化的照顾；强调早期发现并处理病患；强调预防疾病和维护、促进健康；强调在社区场所对患者提供服务，并在必要时协调利用社区内外的其他资源。其最大特点是强调对当事人的“长期负责式照顾”，这意味着其关注的中心是整体的人，并长期对其负有管理责任。只要全科医生与服务对象建立了某种契约关系，就应随时关注他们的身心健康，对其主观和客观的、即刻与长期的各种健康需求作出及时的评价和反应，而且无论何时何地都不能放弃这种责任。由于医生对医学知识的把握胜于患者，因此也可以说，这是一种由医生发起的以人为本、以健康为中心、以需要为基础、以需求为导向的主动服务，确保患者在适宜的地点和时间接受最恰当的医疗照顾。

（三）全科医疗在卫生服务系统中的作用

卫生系统的层级（level of the health system）是指卫生系统针对具体人群，按卫生机构服务功能的不同而划分的功能层次。基层或社区卫生机构，为所在地区提供基本服务；二级卫生服务机构，常由顾问医师或专科医师提供选择性的专科服务；三级卫生服务机构，为有限的、需要复杂的诊疗技术和设备的人群提供服务，通常以医院服务为主。理想的医疗体系应该向每个人提供公平、可及、全面、持续的卫生服务。世界卫生组织确定基本卫生保健是提供基本医疗服务的最有效途径。全科医疗是基本卫生服务系统中的主要医疗服务形式，并以其合理使用卫生资源、有效节约卫生经费的优势，成为

整个卫生保健系统的坚实基础。发展全科医疗是我国医疗卫生事业改革的关键，也是解决医疗卫生事业改革中遇到的重要问题的有效方法。全科医疗根据实际情况和背景开展多种服务，尤其重视常见慢性病的防治，通过干预人们的行为和生活方式，为居民提供预防保健指导，如：老年人往往身患数种疾病，需要综合性医疗服务，而专科医疗分科过细，各个专科医生开出的各种药使患者无所适从，增加医患双方的负担，而全科医疗能够较好地解决上述问题。由此可见，以全科医疗为主体的基本医疗卫生服务系统使人们在一个机构就诊可以解决大部分的健康问题，并且使有限的卫生资源得到了充分的利用，取得更高的效率和更好的成本-效益。全科医疗在我国健康卫生事业中具有不可替代的作用，只有坚持卫生事业改革，推进全科医疗实践，才能从根本上解决现行医疗卫生服务系统与公共卫生服务需求不相适应的矛盾，满足人民群众日益增长的健康服务需求，推进健康卫生事业发展，达到全民健康的目的。

三、全科医生

（一）全科医生的定义

全科医生又称家庭医生（family doctor）。全科/家庭医生（general practitioner/family physician），是全科医疗服务的提供者。全科医生是对个人、家庭和社区提供优质、方便、经济有效的、一体化的基本医疗卫生服务，进行生命、健康与疾病的全过程、全方位负责式管理的医生。全科医生的服务涵盖不同性别、年龄的对象及其所涉及的生理、心理、社会各层面的健康问题。

世界家庭医生组织（WONCA）对全科医生的定义是："全科医生的基本职责是为每一个寻找医疗保健的人提供综合性的医疗保健服务，必要时也安排其他卫生专业人员为其提供有关服务。"美国家庭医师学会（American Academy of Family Physicians，AAFP）对家庭医师的定义为："家庭医师是经过家庭医学这种范围宽广的医学专业教育训练的医生。家庭医师具有独特的态度、技能和知识，使其有资格向家庭的每个成员提供连续性和综合性的医疗照顾、健康维护和预防服务，无论后者的性别、年龄或者健康问题类型是生物医学的、行为的还是社会的。这些家庭医师由于其背景和家庭的相互作用，最具资格服务于每一个患者，并且作为所有健康相关事务的组织者，这些事务包括适当利用专科医生、卫生服务以及社区资源。"

全科医生是接受过全科医学专门训练的新型医生，为个人、家庭和社区提供包括预防、治疗在内的多种卫生保健服务。作为服务协调者，他们能将初级、二级、三级卫生保健服务结合起来。作为负责人、管理者和监督员，他们能提高团队工作的质量和效率。全科医生能与初级保健团队成员共同工作，来整合卫生系统中各个部门的条块分割的服务。

（二）全科医生应具备的基本能力

1. 处理常见健康和疾病问题的能力　能熟练应用全科医学的原则和方法处理社区中常见健康问题；鉴别患者的患病状况，能及时对急症患者进行必要的处理，准确把握转诊时机；能在社区医疗实践中整合其他专科的知识和技能，整合健康教育、心理咨询、心理治疗等技术，适当运用中西医结合的治疗方法，在日常工作中提供以基本医疗为主，预防、诊疗、保健、康复及健康管理一体化服务。

2. 评价个人心理、行为问题的能力　能熟练评价和处理各种行为问题，包括生活事件与应激反应，性格问题，性问题，饮食与营养问题，吸烟、酗酒、药物成瘾问题，儿童、妇女、老年人的特殊问题。熟悉心身疾病产生的机制，掌握心理诊断、心理治疗和心理咨询的基本技能。

3. 家庭评估、家庭访视的能力　能熟练评价家庭的结构、功能、家庭生活周期和家庭资源状况；善于鉴别有问题的家庭及其患病成员，能准确评价家庭功能障碍与个别患病成员之间的互动关系，充分利用家庭资源，为患者提供以家庭为单位的服务；为个人及家庭提供预防性咨询服务；帮助家庭解决存在的问题。

4. 服务社区的能力　具有较强的社会工作能力，能顺利协调和利用社区内外的医疗和非医疗资源，组织必要的社区调查，运用卫生统计和流行病学的方法全面评价社区健康状况，制订和实施社区

卫生计划；能对流行病、传染病、职业病、地方病和慢性病进行有效监测和控制；能胜任初级卫生保健的组织与实施工作，并为社区中的不同人群提供综合性的预防保健服务。

5. 处理医疗相关问题的能力 能妥善处理在医疗过程中可能会遇到的社会与伦理问题，如为患者保守秘密、尊重患者的隐私权、科学理解死亡的定义、熟悉临床药物试验的有关规定等问题；熟悉有关法规，在维护患者及其家庭最佳利益的前提下，尽量避免医疗纠纷的发生。

6. 自我完善与发展的能力 有较强的医疗管理能力，善于把握卫生事业改革与发展的规律与方向，利用各种机会学习新的知识和技能，不断取得进步；能熟练查阅文献资料，在专家的指导下开展科研和教学工作，并善于应对各种各样的困境和挑战。

（三）全科医生的角色

相对不同的层面，全科医生承担着不同的角色。

1. 个人与家庭层面

（1）医生：负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理，包括疾病的早期发现、干预、康复与终末期服务。

（2）健康监护人：负责健康的全面维护，促进健康生活方式的形成；定期进行适宜的健康检查，早期发现并干预危险因素；作为患者与家庭的医疗代理人对外交往，维护当事人的利益。

（3）咨询者：提供健康与疾病的咨询服务，聆听与体会患者的感受，通过有技巧的沟通与患者建立信任关系，对各种有关问题提供详细的资料与解释，指导服务对象进行有成效的自我保健。

（4）教育者：利用各种机会和形式，随时对服务对象（包括健康人、高危人群和患者）进行深入细致的健康教育，保证教育的全面性、科学性和针对性，并进行教育效果评价。

（5）卫生服务协调者：当患者需要时，负责为其提供协调性服务，包括动用家庭、社区、社会资源和各级各类医疗保健资源，与专科医生形成有效的双向转诊关系。

2. 医疗保健与保险体系层面

（1）守门人：作为首诊医生和医疗保险体系的“门户”，为患者提供所需的基本医疗保健，将大多数患者的问题解决在社区，为少数需要专科医疗者联系有选择的会诊/转诊；向保险系统登记注册，取得“守门人”的资格，并严格依据有关规章制度和公正原则、成本-效果原则从事医疗保健活动，与保险系统共同实施基本医疗保险。

（2）团队管理与教育者：作为社区卫生团队的核心人物，在日常医疗保健工作中管理人、财、物，协调好医护、医患关系，以及与社区、社会各方面的关系；组织团队成员的业务发展、审计和继续教育活动，保证服务质量和学术水平。

3. 社会层面

（1）社区与家庭的成员：作为社区和家庭中重要的一员，参与其中的各项活动，与社区和家庭建立亲密无间的人际关系，推动健康的社区环境与家庭环境的建立和维护。

（2）社区健康的组织与监测者：动员组织社区各方面积极因素，协调、建立与管理社区健康网络，利用各种场合做好健康促进、疾病预防和全面健康管理工作，建立与管理社区健康信息网络，运用各类形式的健康档案资料协助做好疾病监测和卫生统计工作。

第三节 | 全科医生岗位胜任力

全科医生的综合素质和能力是提升基层医疗卫生服务能力的关键。培养高水平、高素质的全科医生，对于加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康，具有重要意义。

进入 21 世纪，医学教育正在经历世界范围内的第三次革命，核心是以病人为中心，以系统为基础，以胜任力为导向。岗位胜任力作为人才培养与评价的依据得到广泛的认同，全科医生的培养同样

应以岗位胜任力为核心。国外全科医学发展时间长，对岗位胜任力的研究与应用也较早。目前，欧美一些全科医学发展成熟的国家已经形成了较为规范的全科医生岗位胜任力的标准，并用于全科医生的培养、评价等。虽然我国的全科医学起步较晚，但也有一些专家学者对全科医生岗位胜任力进行了研究，2020 年中国医科大学于晓松教授团队率先提出了中国全科医生岗位胜任力。

一、国外全科医生岗位胜任力

自 20 世纪 70 至 80 年代西方国家将岗位胜任力引入到医学领域后，医学教育逐渐在全球范围内开始转向以患者和人群为中心，以培养胜任力为核心的模式。美国、加拿大、英国、澳大利亚等国全科医学发展较早，全科医生培养体系完善，全科医生岗位胜任力经过多年研究与实践，已颇为完备。

1999 年，美国毕业后医学教育认证委员会（ACGME）提出了医师应具备的患者照顾、医学知识、基于系统的实践、基于实践的学习和提高、职业素养和沟通 6 项岗位胜任力，在此基础上针对家庭（全科）医师的工作特点，ACGME 联合美国家庭医学委员会（ABFP）提出家庭（全科）医师 6 项核心能力，并于 2015 年进行了修订，其名称与医师岗位胜任力相同，具体内容包括：①患者照顾（patient care）：应用生物-心理-社会医学模式，以病人为中心，提供可接受的、高质量且持续的、协调的医疗服务。②医学知识（medical knowledge）：为满足不同患者群体的诊疗需求，掌握全科医生应具备的相关知识。③基于系统的实践（systems-based practice）：能够确保卫生保健系统的高价值、高质量和可运行，具有对全科医生进行高效的管理的能力，同时主动投身于卫生保健系统的宣传工作，以期提高患者健康。④基于实践的学习和提高（practice-based learning and improvement）：具有准确翔实引用科学证据以及评价患者医疗质量的能力。⑤职业素养（professionalism）：能够始终把患者的利益放在首位，对自己和同事保持高标准的道德要求，能够通过识别和妥善管理患者、患者家庭、社会、医疗行业和自身利益之间的潜在冲突来维持互信。⑥沟通（communication）：具备良好的人际沟通技巧，能够与患者、家人以及其他卫生专业人员进行高效的沟通与协作。

20 世纪 90 年代，加拿大皇家内科和外科学会（RCPSC）发布 CanMEDS 框架，用于指导各专业医师的医学教育和实践，并于 2015 年进行了最新一轮的修订，之后加拿大家庭医师学会（CFPC）在 CanMEDS 框架的基础上发布了 CanMEDS—FM（CanMEDS—family medicine）框架，并在 2017 年进行了修订，与 CanMEDS 框架相比，CanMEDS-FM 框架同样将家庭（全科）医师所需具备的能力与知识划分为 7 种特征角色，区别在于将“医学专家”改为“家庭（全科）医学专家”，并相应增加了一些具有家庭（全科）医学特点的指标，而其他内容和 CanMEDS 框架保持一致，具体内容如下：①家庭（全科）医学专家（family medicine expert）：能够为患者及家属提供持久的、互信的、全面的、熟练的诊疗服务，并且能够扮演好家庭（全科）医生工作中的各种角色；②沟通者（communicator）：能够在就诊前、中、后改善医患关系，主动与患者及家属沟通，并妥善预防和解决医患矛盾；③协作者（collaborator）：具有与患者、患者家属、医疗团队、卫生专业人员以及社区保健人员等团队紧密合作的能力，共同诊疗、照顾患者；④管理者（leader）：利用领导和管理技能，参与医疗保健组织，合理地分配、利用资源，为患者提供优质服务；⑤健康促进者（health advocate）：通过熟练使用所学的知识技能改善个人以及群体和社区的健康；⑥研究者（scholar）：具备终身学习的能力和意识，具备思考性的学习能力，同时能够促进医学发展；⑦专业者（professional）：具备较好的素质品质，恪守职业规范，从事医学工作时符合伦理要求。

2002 年，世界家庭医生组织（WONCA）将岗位胜任力应用于家庭（全科）医学领域，提出了家庭（全科）医生核心胜任力模型（WONCA 树状模型），2011 年对该模型进行了修改和完善，具体内容如下：以“情景、态度、科学”3 个工作中应考虑的基本特征作为树根，以“临床任务、与患者沟通、医疗管理”3 个领域作为树干，树枝为以下 6 个岗位胜任力：①以病人为中心照顾（patient-centered care）：以患者及其背景为中心、良好的医患关系、与患者共同诊疗、纵向连续性诊疗。②初级卫生保健能

力(primary care management):医疗协作支持、首诊治疗并以多种方法治疗所有健康问题。③具体问题解决能力(specific problems solving skills):早期未分化阶段的治疗、基于循证医学和预防医学的诊疗决定。④以社区为范围(community orientation)的服务:为社区整体健康负责。⑤综合处理能力(comprehensive approach):急性和慢性健康问题、健康促进。⑥整体性服务(holistic modelling):医学、心理学、社会、文化和与人类存在有关的整体化思维。

2010年,英国皇家全科医师学会(RCGP)发布了关于全科医生的培训课程,在该课程中规定了全科医师应当具备的能力与素质,2019年,RCGP对其进行了修改和完善,具体内容如下:①了解自己并与他人相处(knowing yourself and relating to other):包括与患者建立良好的关系,公平对待他人,展示出符合医生身份的态度与行为等内容。②临床知识和技能的应用(applying clinical knowledge and skill):包括掌握临床检查和程序、采用科学和循证的方法、准确解释结果作出诊断,为各年龄段和不同背景的患者提供临床护理服务、提供紧急护理服务等临床诊疗内容。③管理复杂与长期的病患(managing complex and long-term care):包括使长期患病的人改善健康,管理单个患者的并发症,与同事和团队合作等内容。④在医疗卫生组织和系统中出色工作(working well in organisations and in systems of care):包括终身学习及教学能力、组织管理和领导能力等。⑤以人为中心和社区为导向的照顾(caring for the whole person and the wider community):包括全科医学的整体观念,提供健康、疾病、康复全方位服务,保护个人及当地居民,社区导向,与所在社区建立良好关系等内容。

20世纪90年代初期澳大利亚皇家全科医师协会(RACGP)完善了全科医生的培训课程计划,2019年进行了修订,指出全科医生应具备以下5方面的能力:①专业知识和技能应用(applied professional knowledge and skills):包括全科医生日常诊疗工作,如体格检查、提供诊疗服务、作出医疗决策等内容;②人际沟通与医患关系(communication and the patient-doctor relationship):具备沟通技巧,能够以病人为中心进行健康教育与健康促进等;③群体健康和全科医学(population health and the context of general practice):具备流行病学、公共卫生、预防医学知识,了解家庭对健康及疾病的影响,合理分配卫生资源等;④组织和法律层面(organizational and legal dimension):了解卫生系统组织机构及相关法律法规,掌握信息学技术、临床管理等;⑤职业素养(professional and ethical role):能够对自己保持高水准的道德要求,培养责任意识,具备自我评价的能力等。

二、中国全科医生岗位胜任力及特点

2018年中国医科大学于晓松教授团队获得国家医学考试中心资助项目《基于岗位胜任力的全科医师、助理全科医师和乡村全科执业助理医师的考试设计研究》,完成了中国全科医生岗位胜任力的构建,得到国内同行广泛认可。研究基于中国临床医师岗位胜任力框架,形成涵盖基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、信息利用能力与管理能力、医学知识与终身学习、人际沟通与团队合作、职业素养等6项一级指标,以及60项二级指标的中国全科医师岗位胜任力,具体内容包括:①基本医疗卫生服务:应用生物-心理-社会医学模式,践行全科医疗“全人照顾”的核心理念,提供全生命周期的基本医疗服务;②基本公共卫生服务:负责社区整体健康,能够提供健康教育与健康促进、社区康复等个体和群体全方位服务;③信息利用能力与管理能力:具有收集、运用相关信息进行医疗实践及人群健康管理等能力;④医学知识与终身学习:针对不同患者群体的诊疗需求,掌握应具备的相关知识,并能认识到自身的不足,不断学习,适应社会和行业的发展;⑤人际沟通与团队合作:能够与患者和家人、医疗团队、卫生专业人员以及社区保健人员进行高效的沟通与合作,共同管理患者;⑥职业素养:具有较好的素质品质,恪守职业规范,能够始终把患者的利益放在首位,具备自我评价的能力(详见表1-1)。

NOTES

表 1-1　全科医师岗位胜任力指标体系

一级指标	二级指标
基本医疗卫生服务	1. 全科医师临床思维
	2. 问诊及病史采集
	3. 体格和精神状态检查
	4. 病历及医疗文书书写能力
	5. 辅助检查项目选择与结果解读
	6. 常规诊疗操作技术
	7. 常见病、多发病的诊疗，以及未分化的症状、体征或健康问题的处理
	8. 社区急症的全科医学处理
	9. 转诊能力
	10. 慢性病与健康管理
	11. 以家庭为单位的照顾
	12. 合理用药
	13. 临终关怀
基本公共卫生服务	1. 社区常见传染病的预防与控制
	2. 健康教育与健康促进
	3. 开展基本的心理卫生服务
	4. 社区重点和特殊人群管理
	5. 协助处理突发公共卫生事件
	6. 社区康复
	7. 优生优育指导
	8. 社区卫生诊断能力
信息利用能力与管理能力	1. 医学信息检索、分析与应用
	2. 运用信息技术帮助诊治与进行患者健康教育
	3. 建立与维护社区居民健康档案
	4. 了解医疗卫生体制及相关政策
	5. 了解当地文化背景
	6. 合理控制患者医疗费用
	7. 合理利用社区卫生资源
	8. 教学和指导能力
医学知识与终身学习	1. 医学基础知识
	2. 临床医学知识
	3. 流行病学和医学统计学知识
	4. 循证医学知识
	5. 医学人文知识
	6. 具备一定的外语知识
	7. 学习意识和学习能力
	8. 创新意识与能力
	9. 批判性思维能力
	10. 积极撰写并发表科研文章

NOTES

续表

一级指标	二级指标
人际沟通与团队合作	1. 与患者建立和发展良好的医患关系
	2. 理解、信任并尊重患者及其家属
	3. 保护患者隐私和知情权
	4. 妥善应对在医护过程中产生的伦理问题
	5. 积极预防和化解医患矛盾
	6. 有技巧地向患者传达负面消息
	7. 与患者和家属共同作出决策
	8. 有效口头表达和传递信息能力
	9. 与本团队同事协作
	10. 与其他团队建立良好的合作关系
职业素养	1. 恪守职业医疗法律法规
	2. 基层服务意识
	3. 利他主义和奉献精神
	4. 有效安排自己的工作和职业生涯规划
	5. 自信心与客观的自我评价
	6. 具有爱心、同情心和同理心
	7. 有洞察力
	8. 具备耐心和心理调控能力
	9. 提供公平的医疗卫生保健服务
	10. 具有符合医师身份的仪表妆容
	11. 成就取向

总体上，美国、加拿大、世界家庭医生组织、英国、澳大利亚与我国的全科医师岗位胜任力，在一级指标表述上存在一定差异，但从整体内容上看没有实质差别；二级指标相互交叉，内容基本相同。

各国胜任力在对专业知识、社区导向、人际沟通、职业素养等能力评估上都有明显体现。同时，各国胜任力在构建特点上也有一些不同。首先从胜任力构建的出发点来看，世界家庭医生组织注重以全科医师工作的重点内容作为着眼点，而美国、加拿大和我国的胜任力则注重从医师的整体工作切入进行构建，在原有的临床医师胜任力的框架下根据全科医师工作的特点和需要，将相关指标补充和融入，并兼有各自国情下的特点；英国、澳大利亚介于二者之间，英国侧重全科，而澳大利亚侧重医师整体工作。其次从内容上看，以临床医师岗位胜任力为框架进行全科医师岗位胜任力构建，内容更为详细而具体，依从性更好，我国尤甚。

第四节 | 整合医学与全科医学的关系

一、整合医学

整合医学（integrative medicine）是从人的整体出发，将医学各领域最先进的知识理论和临床各专科最有效的实践经验分别加以有机结合，并根据社会、环境、心理的现实进行修正、调整，使其成为更加符合、更加适合人体健康和疾病诊疗的新的医学体系。

NOTES

人类医学发展的初期属于通科医学，随着医学模式的变化逐渐走向专科化，现在又在更多的层面上走向整合。“整合”一词是近一段时期以来开始在文献中出现的。几十年前，在《精神、身体和健康》一书中首先被提及；提到整合医学（Gordon et al.，1984），它的最初使用可以追溯到 Sri Aurobindo，一个印度政治领袖。这个术语被当代哲学家和超个人心理学家肯·威尔伯（2005 年）应用在他的整体治疗中。在健康和治疗领域的许多思想领袖，包括 Noetic 科学研究所（IONS），均支持这些概念，并鼓励进一步研究，可能被认为是医学模式转变的开始（Schiltz，2005）。20 世纪 90 年代中期，美国在补充和替代医学的基础上提出整合医学，美国的医院开始设立整合医学门诊。1999 年整合医学学术机构成立。2013 年美国专科医生委员会宣布给经过整合医学培训的医生授予整合医学证书。2015 年，美国政府在国立补充医学和替代医学中心的基础上重建了国立补充医学和整合医学中心，该中心隶属于美国医学院。我国的整合医学理念在 20 世纪 90 年代已有萌芽。2009 年，首届“医学发展高峰论坛——医学整合会议”提出了医学整合包括临床学科的整合、临床医学与基础医学的整合、临床医学与公共卫生及预防医学的整合，以及医学与人文的整合。2012 年，首届“整体整合医学高峰论坛”提出“生命整体整合”理念。该理念提出整合医学就是还器官为患者，还症状为疾病，从检验到临床，从药师到医师，身心并重、医护并重、中西医并重、防治并重。

整合医学目的是解决目前专科过度细化、专业过度细化，导致医学知识碎片化，给临床医生诊疗带来局限性的问题。整合医学是传统医学观念的创新，是医学发展历程中从专科化向整体化发展的新阶段。整合医学并不是简单叠加，而是通过学科间相互联系，协同发展。整合医学不仅要求把现在已知各生物因素加以整合，还要将心理因素、社会因素和环境因素也加以整合；不仅要将现存与生命相关各领域最先进的医学发现加以整合，还要将现存与医疗相关各专科最有效的临床经验加以整合；不仅要以呈线性表现的自然科学的单元思维考虑问题，还要以呈非线性表现的哲学的多元思维来分析。这种单元思维向多元思维的提升，通过再整合，构建了更全面、更系统、更科学、更符合自然规律、更适合人体健康维护和疾病诊断、治疗和预防的新医学知识体系。整体医学推动诊疗方式的融合，给临床医学带来更大的发展空间、更有意义的发展前景，推动临床新型诊疗方式发展。

二、整合医学和全科医学的区别与联系

整合医学与全科医学都有整体观理念。但是整合医学是以治疗为目的的新医学知识体系，而全科医学是临床医学的二级学科。首先，整合医学强调人是一个整体，要整体观察、综合评估。全科医学强调“以人为中心”，而非某个器官、某种疾病。其次，二者都有整合观理念。整合医学强调还器官为患者，还症状为疾病，从检验到临床，从药师到医师，身心并重，防治并重。全科医生是在不断协调的关系下照顾整体患者，同时尊重家庭、社区和环境的丰富复杂性和相互作用性。他们承认个人和人与人之间的因素影响健康和疾病，并训练自己在诊治患者时考虑到其生活及生物医学因素的行为和社会效应。全科医生支持将初级保健的规模扩大并应用于增加健康和治愈的可能性上。最后，二者的医学观也是一致的。整合医学强调用科学的理论帮扶医学，用科学的方法研究医学，用科学的数据助诊疾病。全科医学的科研方法也都是为了提高诊疗水平，更好地服务基本医疗。

全科医学与整合医学是有区别的。整合医学是体系，而全科医学是完整的学科，全科医学有独立的哲学观、价值体系。虽然同为整合，但整合医学是一定方向的纵向整合，是综合治疗；而全科医学是一定程度的横向整合，包括疾病本身、心理、社会等方面的整合。在解决问题方面整合医学与全科医学也有不同，整合医学是为了“看得好”问题，而全科医学是为了“看得了”问题。

整合医学是现代医学的必然趋势。全科医学是整合医学的枢纽，全科医生是整合医学的协调员。有效地协调各专科服务、整合各专科的意见是全科医生的重要任务。疑难病多学科整合门诊是整合医学的新尝试，这种模式是由全科医生协调的整合医学实践。整合医学是全科医生管理患者的方法论，全科医生必须具有高度专业的理论和诊治水平，同时具有高水平的医疗协调能力，把一切有利于患者的医疗单元有机地整合在一起，使患者得到最好的医疗保健和健康支持。整合就是要用整体观

来规范医疗，就是要各专科在全科的导向下各司其职。建立高质量的全科医生队伍，协调各专科，培养专科医生之间的协作意识，形成整合医学的服务模式，通过整合医学模式达到理想的全人医疗。全科医生是整合医学实践者，应积极参与整合医学研究，运用循证医学方法，把最新的研究结果用于整合医学实践。

（于晓松）

思考题

1. 全科医学的定义与学科特点是什么？
2. 全科医疗在卫生保健系统中的作用是什么？
3. 全科医疗的基本原则有哪些？
4. 中国全科医生岗位胜任力包括哪些？
5. 何为中国全科医生规范化培养？全科医生应具备怎样的素质？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图